



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هدي زكي حسن ابراهيم
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الزيتون
العنوان : تنن
رقم البطاقة : 26312240101025 رقم التليفون : 01000353374
العمر (تاريخ الميلاد) : 24-12-1963 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر بالصبغه
قسم العلاج :
الأورام

[11127]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هدي زكي حسن ابراهيم National ID: 26312240101025	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

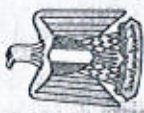
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest and abdomen
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٣/١٠/١٠١٠٢٥

٢٠٢٣/١٠/١٠١٠٢٥

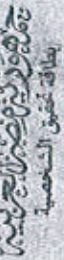
بنون عمل

مسترجة

السيد نبوي محمد

البيانات: ٢٠٢٣/١٠/١٠١٠٢٥



٢٠٢٣/١٠/١٠١٠٢٥

٢٠٢٣/١٠/١٠١٠٢٥

بنون عمل

مسترجة

السيد نبوي محمد

البيانات: ٢٠٢٣/١٠/١٠١٠٢٥



Patient Name: Hoda Zaky Hassan Ibrahim	Date : 05/05/2025
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 59 Year(s)
Medical ID: 293/2022	Pat. ID: 12270

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN,
AND PELVIS: -**

Findings:

As compared to prior study dated 12/12/2024

I Chest:-

- **Status post left MRM showing no operative bed masses or collections.**
- ***Still noted*** enlarged ***right*** axillary lymph nodes, the largest measures about 2.2x1.9 cm in axial dimensions.
- **Rather stationary size of the** pleural based right upper lung lobe pulmonary nodule is still seen still measures 7 mm.
- **No otherwise suspicious pulmonary nodules masses or cavitary lesions.**
- **Stationary** enlarged mediastinal lymph nodes the largest one still seen at prevascular group measures 1.3 x 2.2 cm.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Mild cardiomegaly. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Bilateral elastofibroma dorsi are still noted.
- Hiatus hernia is noted as well.

II Abdomen & pelvis:

- **Further regression of the size** of multiple variable sized peritoneal nodules with the largest still seen attached to the anterior abdominal wall epigastric region seen measuring about 4 X 0.7 cm compared to 5.4x1.2 cm.
- Status post gastric surgery with multiple left hypochondrial surgical clips with stable related soft tissue sheets.
- **stable course of previously noted** abdominal greater and lesser sac moderate fluid collection being mild in this study.
- **Regression regarding the size** of the bilateral inguinal lymph nodes the largest measures 0.8x2.4 cm compared to 1 X 2.8 cm.
- **Still noted rather unchanged** Right lateral abdominal wall defect likely stoma with parastomal hernia containing mesentery and intestinal loops, surrounded by fat stranding.
- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.

- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- Spondylodegenerative changes are noted.
- L1 osseous hemangioma is seen.

Opinion:

- *Status post left mastectomy showing overall mild regressive course as described.*

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:

1- Name : هدى زكي حسن ابراهيم

Sex:

MDT form

3- Medical number:
Female

83054063

Old Med:

Old Med:

293-2022

2-ID number: 26312240101025

Patient Age: 51 Y



Family history

Family history

Phone

Phone

01090704618

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT

marital status

Marital status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

2025-04-20

Co morbidity

Co morbidity

ON GLEEVEC

Menopausal status

Menopausal status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX
IDC

BX COMMENT

ER
8/8

ER COMMENT

PR
5/8

PR COMMENT

Her 2 Neu
3

Her 2 Neu COMMENT

SISH

SISH COMMENT

Ki67

Ki67 COMMENT

T
2

N
1

M
0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

POSTMENPUSAL LOCALLY ADVANCED LT BC ,,4AC,4 TAXOTERE,,4 HERCEPTIN +PERJETA
ON 7/2022 LT SKIN SPARING MASTECTOMY+SLNB-->YPT0 YPN1/11
PT RECEIVED 2 CYCLES OF KADCYLA AND LOST FU FROM 10/1/2023
3/2023-->STARTED HORMONAL TTT,,CTS PERITONEAL NODAL
PT RECEIVED KADCYLA FROM 10/4/2022 TO 31/5/2023 AND
PERITONEAL NODAL BX-->HER2 -VE,,GATA3 -VE
LAST MDT 30/7/2023-->FOR REMDT AFTER C-KIT RESULTS
LAST MDT resume arimidex and re mdt (as anti her2 was refused since 5/2023)
pt on gleevic not complaint from it PS 3---4
ct: newly developed med LN & MULTIPLE
pt continued aramedix and kadsyla
8/2024 ct PD regarding peritoneal mets (this mets is mostly from GIST as the pt had pervious biopsy)
RECEIVE 8 CYCLE KADYCLA & start AI 3/2023
pt received gleevic

MDT OUTCOME & PLAN

continue on gleevic + AI
new CT-CAP requested



Patient Name : الأستاذ / هدى زكى حسن ابراهيم
Patient No. : 26312240101025
Path No. : 1193/23
Sex : Female
Age : 59 Y
Referring Doc :

Request No. : 13008528
Request Date : 18/04/2023
Verification Date : 09/09/2023
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

CLINICAL DATA

Breast cancer with peritoneal nodule

NATURE OF SPECIMEN

Tru cut biopsy from peritoneal nodule, collected at 18/4/2023

GROSS EXAMINATION

Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for SOX10 & CD117

MICROSCOPIC EXAMINATION

- * Nests of epithelioid cells.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER:
- * SOX10: Negative in neoplastic cells.
- * C-kit (CD117): Positive in neoplastic cells.

DIAGNOSIS

Peritoneal nodule, Tru cut biopsy:
Compatible with Gastrointestinal stromal tumor (GIST).

Signature

Prof. Dr. Gamal Abdelaty

Dr.Marwa Mahmoud

Verified by :

Printing Date : 01/10/2023 12:22:31

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



Patient Name : الأستاذ / هدى زكى حسن ابراهيم
Patient No. : 26312240101025
Path No. : SR-86/22
Sex : Female
Age : 58 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003134
Request Date : 07/02/2022
Verification Date : 08/02/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Lt breast mass & Lt axillary nodal metastasis

Nature of the specimen: Slide revision

Gross Examination:
two block (590059), & 6 slide

Microscopic examination:

- Histological type: IDC
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII(2+2+1)
- Angioinvasion: NO
- Ductal carcinoma in situ:NO
- Tumor extent
 - o Number: N/A
 - o Size:N/A
 - o Skin involvement:N/A
- Lymph node involvement:N/A
- Resection Margins:N/A
- o Free /DCIS/ invasive carcinoma
- Histologic response to therapy: N/A
- Additional pathologic findings: slide of LN core showed metastatic IDC.

Diagnosis:

Lt breast cancer, slide revision:

1) Invasive duct carcinoma GII

• Biomarkers (done on LN):

- o ER: strong nuclear staining in 80% nuclear reaction (Allred score 8/8)
- o PR: strong nuclear staining in 35% nuclear reaction (Allred score 6/8)

Verified by :

Printing Date : 01/10/2023 12:22:30

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa

الأستاذ / هدى زكى حسن ابراهيم :

: 26312240101025

: SR-86/22

: Female

: 58 Y

Attending Doc :

Request No. : 13003134

Request Date : 07/02/2022

Verification Date : 08/02/2022

Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

- o Her2: strong complete membranous staining in > 10% of tumor cells (score 3+)
- o Ki67: 20% nuclear reaction
- 2) Axillary LN: metastatic IDC.

Prof. Gamal Abdelaty
Dr.Rana Fathy

Verified by:

Printing Date : 01/10/2023 12:22:30

Page 2 of 2

Printing By : Ali mostafa

Registered by : .marwa mohamed youss